2.3.2.1. 검체검사 결과 보고 - 진단검사의학과

제 정 일	2006.04.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	진단검사의학과				
유 관 부 서	의료질향상 및 환자안전위원회				

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 2.3.2 검체검사 결과 보고 절차 JCI Standard 7th Edition: AOP.5.1, 5.4, 5.5, 5.9.1, 6.1, 6.3~6.6, IPSG.2, 2.1

제1조 (목적)

1. 검체검사의 결과 보고체계 및 관련 의사소통 절차를 확립하여 적절한 진료 및 환자의 안전을 도모하고, 환자의 생명을 위협하거나 위해를 줄 수 있는 검사결과 이상치 발생 시 신속하게 대응하기 위함이다.

제2조 (정의)

제3조 (절차)

1. 검체검사 결과보고
   1) 검사종류별 보고방법
      (1) 검사결과 보고는 검사 종목에 따라 수치, 문자, 서식지 형식의 방식으로 보고한다.
      (2) 검사부서는 각각의 검사결과의 판독 및 보고에 대한 기준 범위(참고치)를 확립하며 세부지침은 부서별 업무규정에 따른다.
   2) 검사결과 보고시간(Turn-Around Time, TAT)
      (1) 진단검사의학과 접수시간부터 결과보고 시간까지로 한다.
      (2) 정규, 응급, 당일, 응급진료센터 검사로 구분하여 TAT를 관리한다. 내부검사 외 외주의뢰 검사도 모두 포함한다.
      (3) 정규 검사: 응급(STAT)으로 처방되지 않은 병동 및 외래검사(응급진료센터 제외)이며, TAT는 각 검사별 설정 시간에 따른다.
      (4) 응급 검사: 병실에서 응급(STAT)으로 처방된 검사이며, TAT는 60분으로 한다.
      (5) 당일 검사: 외래에서 응급(STAT)으로 처방된 검사 또는 외래 진료 전 검사이며, TAT는 각 검사별 설정 시간에 따른다.
      (6) 응급진료센터: 응급진료센터는 응급으로 처방이 나지 않았더라도 응급에 준해 처리한다.

2. 이상 검사결과 보고(Critical Value Report, CVR)
   1) 보고 대상 및 기준: 진단검사의학과 검사 유형에 따라 이상검사결과 보고 기준을 확립하며, 세부지침은 [부록3. 진단검사의학과 CVR 지침]을 참고한다.
   2) 이상검사결과 확인 시 보고 절차
      (1) 검사결과에서 Critical Value가 확인되면 담당 임상병리사가 30분 이내 담당 의료진에게

문자 전송 또는 유선 또는 이메일로 알린다.

① 1차 보고

a. SMS 문자: 처방의, 주치의(담당교수)에게 결과 입력 후 30분 이내에 SMS(Short Message Service) 문자 전송

b. 전화: 입원환자의 경우 SMS 연락이 안 될 경우 병동 간호사에게 전화 후 기록을 남긴다.

② 2차 보고: 1차 보고 후 30분 이내에 임상과 확인이 안 된 경우 주치의(담당교수), 처방의에게 SMS 1차 재 발송(자동 재 발송) 한다.

③ 3차 보고: 2차 보고 후 1시간 이내에 임상과 확인이 안 된 경우 주치의(담당교수), 처방의에게 SMS 2차 재 발송(자동 재 발송) 한다.

④ 이메일 발송: 3차 보고 후 임상과 확인이 안 된 경우 결과에 대해 24시간 (휴일의 경우 48시간) 이내 주치의(담당교수), 처방의에게 E-mail로 보고한다.

⑤ 동일환자에서 반복된 Critical Value가 발생할 경우 2주일간 SMS 발송을 생략할 수 있다.

⑥ POCT의 경우 검사자가 즉시 주치의(담당교수)/처방의에게 보고한다.

⑦ 진단검사의학과 파트별 경고치 보고 원칙

파트	SMS 문자 전송	전화 보고	이메일 발송	2주 이내 중복 보고
혈액학파트	O	O	O	O
생화학파트	O	O	O	X
응급검사파트	O	O	O	X
암병원파트	O	O	O	X
현장검사파트	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
미생물파트	O	O	O	X

(2) 검사부서에서는 이상검사결과 리스트 및 보고 현황을 관리한다.

(3) 결과 확인 방법: 경고치 확인은 다음 세 가지 중 한가지 이상의 방법을 사용할 수 있다.

① 처방과의 주치의(담당교수) 및 처방의, 전공의(담당의사) 등이 통합검사결과 조회

② SMS 문자를 받은 처방의, 주치의(담당교수)가 문자 내 URL을 클릭하여 수신 확인

③ 처방의, 주치의(담당교수)가 진료 EHR의 “이상결과보고(CVR)조회”에서 확인

3. 중간결과 보고

1) 중간보고 기준

(1) 항목들은 교과서와 실제 임상의 요구를 정리하여 설정한다.

(2) 환자의 진단과 효율적인 치료에 도움을 제공하기 위하여 신속히 중간보고를 한다.

파트	검사항목	중간 결과 보고 기준
미생물	혈액배양	배양 양성인 경우 Gram stain 결과를 배지명과 함께 보고
		미생물혈액배양 배양 음성인 경우 배양 2일 후 보고
	미생물 척수액배양	배양 양성인 경우 추종되는 세균의 예비 결과를 증식정도와 함께 보고

2) 중간보고 보고방법
   (1) 미생물 파트의 중간 결과는 전산 LIS에 입력하여 EMR에 자동으로 보고한다.
   (2) 전산 장애 및 장비 이상 발견 시 간호사에게 전화 후 수기로 기록을 남기고, 전산 연락 사항에 기록을 남긴다.
3) 결과 확인
   (1) 처방과의 주치의(담당교수) 및 처방의, 전공의(담당의사), 병동 간호사 등이 확인한다.
4) 중간보고를 한 경우 해당 부서에서 중간 보고된 리스트를 관리한다.

4. 보고된 검사결과가 변경될 경우 보고절차
   1) 동일검사 결과보고의 결론이 변경된 경우에는 의료진에게 문자 또는 유선으로 알린다.
   2) 유선으로 검사결과 보고 시, 세브란스병원 내규 [1.2.1. 구두/전화처방]에 따른다.

5. 결과보고소요시간(TAT)은 병원에서 정한 지침에 따르며, 세부적인 지침은 부서별 및 검사항목별로 정한다. TAT 결과를 모니터링하고 분기별로 보고하며, 이를 의료진간 공유한다.

제4조 (부록)
1. 진단검사의학과 TAT 지침
2. 진단검사의학과 TAT 지침 – 검사별 최대보고시간
3. 진단검사의학과 CVR 지침

제5조 (참고)
1. 환자안전 주의경보 '이상검사결과의 보고(CVR) 지연 또는 누락' (의료기관평가인증원 중앙환자안전센터, 2020.10)

내규의 제·개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)
1. 이 내규는 2006년 4월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)
1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인 : 세브란스병원장 이 강 영 (인)